البطن بيت الداء

من حكمة النبي الى ثورة الاوزمبك

The Stomach Is the Home of Disease

From Prophetic Wisdom to the Ozempic Revolution

د. فضل محمد الاكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

البطن بيت الداء

من حكمة النبي إلى ثورة الأوزمبك — كيف أثبتت أدوية GLP-1 ومثبطات SGLT2 وجراحة التكميم حكمة الإسلام

The Stomach Is the Home of Disease

How GLP-1 Drugs, SGLT2 Inhibitors & Metabolic Surgery Confirm Ancient Islamic Insights

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

University of Michigan, Ann Arbor

الطبعة الأولى — 2026
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

❖ إهداء ❖

إلى كل باحث عن الحقيقة، يدرك أن العلم الحديث ما هو إلا تأكيد لما جاء به الوحي قبل أربعة عشر قرنًا.

وإلى كل مريض يبحث عن الشفاء، ليعلم أن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم دواءً لكل داء.

وإلى كل طبيب وباحث يسعى لفهم أسرار الجسد البشري، ليتيقن أن القرآن والسنة سبقا الطب الحديث بقرون.

فهرس المحتويات

Table of Contents

المقدمة

الفصل الأول: حديث النبي ﷺ في الاعتدال في الطعام

الفصل الثاني: الإمام الغزالي وآفات شره الطعام

الفصل الثالث: ثورة أدوية GLP-1 — من الأوزمبك إلى المونجارو

الفصل الرابع: مثبطات SGLT2 وحماية الكلى

الفصل الخامس: جراحة تكميم المعدة VSG والتغيرات الجزيئية

الفصل السادس: أبحاثنا المنشورة في مجال أمراض الكلى والسكري

الفصل السابع: الجسر بين الحكمة الإسلامية والطب الحديث

الفصل الثامن: توصيات عملية — من الحكمة النبوية إلى التطبيق اليومي

الخاتمة

المراجع العلمية

القسم الإنجليزي — English Translation Section

نبذة عن المؤلف / About the Author

مؤلفات المؤلف / Author's Publications

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

سورة الأعراف: 31

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

يشهد عالمنا اليوم ثورة طبية غير مسبوقة في مجال علاج السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها. فأدوية مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) مثل الأوزمبك والويغوفي والمونجارو قد غيّرت مفاهيم الطب الحديث جذريًا. ولكن المتأمل في هذه الثورة الطبية يجد أن جوهرها ليس جديدًا، بل هو تأكيد علمي حديث لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا.

لقد نبّه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الإفراط في الطعام بقوله الشريف: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». وهذا الحديث يُعدّ أساس الطب الوقائي في الإسلام. وقد أكد الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أن «البطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات».

في هذا الكتاب، نستعرض كيف أن الأبحاث الطبية الحديثة — بما فيها أبحاثنا المنشورة في مجال مثبطات SGLT2 وجراحة تكميم المعدة (VSG) في جامعة ميشيغان — تؤكد هذه الحقائق الإسلامية العظيمة. إن تقليل الطعام والاعتدال فيه ليس مجرد نصيحة روحية، بل هو أساس الصحة والعافية الذي يثبته العلم يومًا بعد يوم.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

سورة الأعراف: 31

الفصل الأول

حديث النبي ﷺ في الاعتدال في الطعام

«ما ملأ آدَميٌّ وِعاءً شرًّا من بطنٍ، بحَسْبِ ابنِ آدمَ لُقَيماتٌ يُقِمْنَ صُلبَه، فإن كان لا مَحالَةَ فثُلُثٌ لطعامِه وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَسِه»

رواه الترمذي (2380) وصححه الألباني — عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه

أولًا: تخريج الحديث ودرجته

هذا الحديث الشريف رواه الإمام أحمد في مسنده (17186)، والترمذي في سننه (2380)، والنسائي (6738)، وابن ماجه (3349). وقد صححه الألباني رحمه الله،

وحسّنه الترمذي والبغوي وابن حجر. وأورده ابن حبان في صحيحه (4590)، وصححه الحاكم في المستدرك.

ثانيًا: شرح الحديث — المراتب الثلاث

المرتبة الأولى: التحذير من ملء البطن

شبّه النبي ﷺ البطن بالوعاء، ووصف ملأه بأنه شر ما يفعله الإنسان. فالمعدة الممتلئة تُسبب التخمة، وتُثقل الجسد، وتُضعف العقل، وتُولّد الأمراض. وقد قال ابن باز رحمه الله: «ملء البطون فيه خطر كبير، فهو يسبب التخمة وأمراضًا كثيرة».

المرتبة الثانية: الاكتفاء بلقيمات

وهي المرتبة المثلى، حيث يكتفي الإنسان بما يقيم صلبه ويمده بالطاقة اللازمة. وهذا ما يؤكده الطب الحديث تحت مسمى «تقييد السعرات الحرارية» (Caloric Restriction) الذي ثبت أنه يطيل العمر ويقي من الأمراض المزمنة.

> **حقيقة علمية:** أثبتت عشرات الدراسات أن تقليل السعرات الحرارية بنسبة 20-30% يؤدي إلى إطالة العمر وتقليل الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل مخاطر السرطان وأمراض القلب.

المرتبة الثالثة: تقسيم المعدة أثلاثًا

وهي رخصة لمن لم يستطع الاكتفاء باللقيمات: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفَس. هذا التقسيم يضمن عدم امتلاء المعدة بالكامل، مما يسهّل الهضم ويمنع الارتجاع.

ثالثًا: أقوال العلماء في الحديث

قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد رُوِي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت دكاكين الصيدليات». وهذا القول من طبيب متخصص في القرن الثالث الهجري يؤكد أن أهل الاختصاص أدركوا منذ القدم عمق الحكمة الطبية في هذا الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع فيه آداب الأكل والشرب كلها». وقال الإمام النووي: «فيه الحث على التقلل من الطعام والاكتفاء بما يسد الرمق ويقيم البدن».

وقد نقل الحافظ المنذري رحمه الله أن الحارث بن كلدة — طبيب العرب المشهور — قال: «الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعوّدوا كل جسم ما اعتاد». وهذا يتوافق تمامًا مع المبدأ النبوي في تقليل الطعام والاعتدال فيه.

رابعًا: الإعجاز العلمي في الحديث

الطب الحديث يؤكد أن الإفراط في الطعام هو السبب الرئيسي للسمنة المؤدية إلى: السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، والكبد الدهني (MASH)، وتوقف التنفس أثناء النوم، وأنواع عديدة من السرطان. وقد ذُكر أن طبيبًا أمريكيًا أسلم بسبب هذا الحديث وقال: «هذه أصول الطب، ولو أن الناس نفذوها ما كاد يمرض أحد».

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

سورة الفرقان: 67

الفصل الثاني

الإمام الغزالي وآفات شره الطعام

خصص الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (450-505 هـ) في كتابه «إحياء علوم الدين» بابًا كاملًا أسماه «كتاب كسر الشهوتين»، وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات.

أولًا: البطن ينبوع الشهوات

قال الغزالي: «أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أُخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات».

ثم يبيّن كيف أن شهوة البطن تتسلسل منها سائر الشهوات: شهوة الفرج، ثم الرغبة في المال والجاه، ثم المنافسات والمحاسدات، ثم الرياء والكبرياء، ثم الحقد والحسد. فكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وبطر الشبع.

ثانيًا: فوائد تقليل الطعام الثمانية

الأولى: رقة القلب ولذة المناجاة. **الثانية:** ذل النفس وزوال البطر. **الثالثة:** تذكر بلاء الله. **الرابعة:** تذكر المساكين. **الخامسة:** كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة. **السادسة:** دفع النوم الكثير. **السابعة:** تيسير المواظبة على العبادة. **الثامنة:** صحة البدن ودفع الأمراض، فإن سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق.

> **التوافق مع الطب الحديث:** الفائدة الثامنة (صحة البدن ودفع الأمراض) تتطابق مع الدراسات الحديثة عن فوائد تقليل الطعام: تحسين صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتحسين حساسية الأنسولين، وإطالة العمر.

ثالثًا: آفات الشبع العشر

عدّد الغزالي عشر آفات للشبع المفرط أبرزها: قسوة القلب، وفتنة الأعضاء وانبعاثها للفساد، وقلة الفهم فإن «البِطنة تُذهب الفطنة».

رابعًا: آفات الشبع المفرط عند الغزالي — تحليل تفصيلي

الآفة الأولى: قسوة القلب وذهاب نوره، فالقلب الممتلئ بأثر الطعام لا يتسع للتفكر والتدبر. وهذا ما يؤكده الطب الحديث: الإفراط في الطعام يسبب خمولًا ذهنيًا وصعوبة في التركيز بعد الوجبات الثقيلة بسبب تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي.

الآفة الثانية: فتنة الأعضاء وهيجانها وانبعاثها للفضول والفساد. فالطاقة الزائدة من كثرة الطعام تتحول إلى طاقة تدفع نحو الشهوات والمعاصي.

الآفة الثالثة: قلة الفهم والعلم، فإن «البِطنة تُذهب الفطنة». وقد أثبتت دراسات حديثة أن السمنة ترتبط بانخفاض في الوظائف الإدراكية وزيادة خطر الخرف ومرض ألزهايمر — وهذا ما دفع الباحثين لتجربة سيماغلوتيد في علاج ألزهايمر!

الآفة الرابعة: ثقل البدن عن العبادة والطاعة. والمعنى الصحي واضح: السمنة تحدّ من الحركة والنشاط البدني.

الآفة الخامسة: كثرة الأحلام المزعجة والأفكار المشوشة أثناء النوم. وقد ربط الطب الحديث بين السمنة وتوقف التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea) واضطرابات النوم.

خامسًا: منهج الغزالي في كسر شهوة البطن

وضع الغزالي منهجًا عمليًا يقوم على: أكل الحلال، وتقليل الكمية تدريجيًا، وتأخير وقت الطعام، وترك المشتهيات. وقال: «فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه، فينبغي أن يتدرج قليلًا قليلًا». وهذا يتوافق مع «الصيام المتقطع» و«تقييد السعرات الحرارية».

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

سورة الإسراء: 82

الفصل الثالث

ثورة أدوية GLP-1

أولًا: ما هي أدوية GLP-1؟

GLP-1 هو هرمون يُفرز من الأمعاء بعد الطعام. يُنظم سكر الدم والشهية والهضم. أدوية مستقبلاته تحاكي هذا الهرمون فتقلل الشهية وتبطئ إفراغ المعدة وتحسّن إفراز الأنسولين. الاختراق كان في هندسة نظائر مستقرة مقاومة للتحلل الإنزيمي.

ثانيًا: الأدوية المتاحة حتى 2026

سيماغلوتيد (Semaglutide): أوزمبك (للسكري)، ويغوفي (للسمنة)، ريبلسس (فموي). إنقاص وزن 15-20%. اعتمادات إضافية: أمراض القلب (2024)، الكلى المزمنة (يناير 2025)، الكبد الدهني MASH (أغسطس 2025).

تيرزيباتيد (Tirzepatide): مونجارو (للسكري)، زيبباوند (للسمنة). ناهض مزدوج GLP-1/GIP. إنقاص وزن 20-26%. معتمد لتوقف التنفس أثناء النوم (2024).

أدوية فموية جديدة: ويغوفي الفموي (يناير 2026). أورفورغليبرون (GLP-1 فموي غير ببتيدي) ينتظر الموافقة في 2026.

ثالثًا: التطبيقات المتوسعة

تتوسع لتشمل: أمراض القلب، الكلى المزمنة، الكبد الدهني، توقف التنفس أثناء النوم، مرض ألزهايمر (تجارب EVOKE المرحلة 3)، اضطرابات الإدمان (أكثر من 15 تجربة جارية)، أمراض الشرايين الطرفية.

رابعًا: الأدوية قيد التطوير والمستقبل

هناك عدة أدوية واعدة في مراحل التطوير المتقدمة:

ريتاتروتيد (Retatrutide): ناهض ثلاثي لمستقبلات GLP-1 وGIP والجلوكاجون. أظهر في تجارب المرحلة الثانية نتائج مذهلة في إنقاص الوزن تصل إلى 24% في 48 أسبوعًا، مما يجعله من أقوى الأدوية المتوقعة في هذا المجال.

كاغريسيما (CagriSema): دواء مركب من كاغريلينتيد وسيماغلوتيد، يُتوقع صدور قرار FDA بشأنه في 2026. يجمع بين تأثيرات GLP-1 والأميلين لتحقيق إنقاص وزن أكبر.

VK2735: ناهض مزدوج GLP-1/GIP من شركة Viking Therapeutics، يُطوِّر بشكل فموي وحقني، ومن المتوقع اعتماده في 2028 أو بعدها.

كما أن الأبحاث تتجه نحو أدوية تحافظ على الكتلة العضلية أثناء إنقاص الوزن، وهو أحد التحديات الرئيسية للأدوية الحالية. وقد أعلنت الجمعية الأمريكية للسكري في يونيو 2025 عن علاجات GLP-1 جديدة تحسّن جودة إنقاص الوزن بتحسين الحفاظ على العضلات.

خامسًا: حجم السوق

70 مليار دولار (2025)، متوقع 200+ مليار (2033). نوفو نورديسك أصبحت أعلى شركة أوروبية قيمة سوقية. مبيعات أوزمبك وحده تجاوزت 18.5 مليار دولار في 2024.

> **كيف تعمل هذه الأدوية؟** تقلل الشهية بنسبة 20-30% وتبطئ إفراغ المعدة — أي تحقق دوائيًا ما أرشد إليه النبي ﷺ سلوكيًا!

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

سورة الشعراء: 80

الفصل الرابع

مثبطات SGLT2 وحماية الكلى

أولًا: آلية العمل

بروتين SGLT2 في خلايا الأنابيب الكلوية القريبة يعيد امتصاص 90% من الجلوكوز. تثبيطه دوائيًا يتخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول. الفوائد تتجاوز التحكم في السكر بكثير.

ثانيًا: الاعتمادات

معتمدة لعلاج: السكري من النوع الثاني، وقصور القلب بأنواعه، وأمراض الكلى المزمنة.

ثالثًا: دراستنا في جامعة ميشيغان (JCI, 2023)

في دراستنا (Schaub, AlAkwaa et al., JCI 2023) استخدمنا تسلسل الحمض النووي الريبي للخلايا المفردة (scRNAseq) من خزعات كلوية لشباب مصابين بالسكري (12-21 سنة). النتائج:

- تعبير SGLT2 يقتصر على خلايا الأنابيب القريبة.
- قمع جينات التحلل السكري والدورة الحمضية الثلاثية (TCA Cycle).
- تعزيز مسارات AMPK وFOXO3 (حماية خلوية).
- تراجع نشاط مسار mTORC1 (التهاب وتليف).

رابعًا: نتائج إضافية من أبحاثنا

كشفت أبحاثنا الإضافية المقدمة في المؤتمرات الدولية عن جوانب جديدة لآليات عمل مثبطات SGLT2:

تحسين أكسجة الكلى: أظهرنا في بحث WCN23-0761 أن مثبطات SGLT2 قد تحسّن من مستوى الأكسجين في الأنسجة الكلوية وتخفف من تعبير بروتين HIF1A (العامل المحفِّز بنقص الأكسجين) في الشباب المصابين بالسكري. وهذا يعني أن هذه الأدوية لا تحمي الكلى فقط من الناحية الأيضية، بل أيضًا من ناحية الإمداد بالأكسجين.

تعزيز مسار الميتالوثيونين: في بحث WCN23-0471، اكتشفنا أن مثبطات SGLT2 تعزز مسار الميتالوثيونين في الأنابيب القريبة. الميتالوثيونين هو بروتين يربط المعادن الثقيلة ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، مما يضيف بُعدًا جديدًا لآلية الحماية الكلوية.

تأثيرات عبر أجزاء النفرون: من أكثر النتائج إثارة أن التغيرات الانتساخية لم تقتصر على خلايا الأنابيب القريبة (حيث يُعبَّر عن SGLT2)، بل امتدت إلى النفرون البعيد أيضًا. هذا يشير إلى تأثيرات غير مباشرة (non-cell autonomous) لهذه الأدوية تتجاوز موقع عملها المباشر.

> **أهمية مسار mTORC1:** منظم رئيسي للنمو الخلوي. فرط نشاطه يرتبط بالالتهاب والتليف. تثبيطه (بمثبطات SGLT2 أو تقليل الطعام) يحمي الكلى والقلب.

وَفِي أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ

سورة الذاريات: 21

الفصل الخامس

جراحة تكميم المعدة VSG

جراحة VSG تزيل 80% من المعدة — تحقق عمليًا ما أرشد إليه النبي ﷺ: تقليل الطعام جذريًا.

أولًا: دراستنا (Naik, Alakwaa et al., 2026)

درسنا التغيرات الكلوية بعد VSG في شباب مصابين بالسكري والسمنة المفرطة ضمن مشروع IMPROVE-T2D، باستخدام تحليلات متعددة: أيض شامل، حجم كلوي، تقييم نسيجي، وscRNAseq قبل وبعد 12 شهرًا.

ثانيًا: النتائج

فقدان وزن كبير وتحسن حساسية الأنسولين. كلويًا: تراجع الترشيح المفرط، وانخفاض حجم الكلى، وتقلص المصفوفة الميزانقية. جزيئيًا: قمع جينات التحلل السكري وTCA، وتنشيط AMPK/FOXO3، وتراجع mTORC1 وJAK-STAT الالتهابي.

ثالثًا: التحليل البروتيومي من مشروع Teen-LABS

لتأكيد نتائجنا، استخدمنا بيانات البروتيوميات المنتشرة في الدم من مشروع مستقل — Teen-LABS (Teen Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery) — الذي شمل 64 شابًا يعانون من السمنة (مع أو بدون سكري) خضعوا لجراحة تكميم المعدة. ربطنا بين البروتينات المنتشرة في الدم وبيانات النسخ الجيني الكلوية، وأظهرت النتائج توافقًا ملحوظًا: انخفاض في البروتينات المرتبطة بمسار JAK-STAT الالتهابي بعد الجراحة ارتبط بتراجع التعبير عن الجينات المقابلة في خلايا الأنابيب الكلوية القريبة.

هذا التحليل المتكامل (multi-omics integration) يعطي ثقة أكبر في النتائج، حيث أظهرت مجموعتان مستقلتان من المرضى نفس التغيرات الجزيئية بعد تقليل حجم المعدة.

رابعًا: التشابه مع مثبطات SGLT2

التشابه المذهل بين VSG وSGLT2i يشير إلى آلية مشتركة: تقليل الحمل الأيضي على الكلى.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

سورة طه: 114

الفصل السادس

أبحاثنا المنشورة

1. دراسة مثبطات SGLT2 (JCI, 2023)

Schaub JA*, AlAkwaa FM*, McCown PJ*, Naik AS* et al. J Clin Invest. 2023;133(5):e164486. (* مساهمون متساوون).
نُشر تعليق تحريري مرافق يؤكد أهمية النتائج.

2. تأثير جراحة التكميم (2026)

Naik AS, Alakwaa FM et al. Metabolic surgery mitigates early kidney injury by suppressing mTORC1/JAK-STAT signaling. أول دراسة scRNAseq لتأثير VSG على الكلى في الشباب.

3. عامل نمو البشرة الكلوي (Kidney International, 2023)

مثبطات SGLT2 تزيد تعبير EGF في الكلى وتحسن نتائج مرضى السكري.

4. أبحاث المؤتمرات الدولية

WCN23-0761: تحسين أكسجة الكلى بمثبطات SGLT2. WCN23-0471: تعزيز مسار الميتالوثيونين. WCN23-0472: آليات SGLT2 الجزيئية.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

سورة فصلت: 53

الفصل السابع

الجسر بين الحكمة الإسلامية والطب الحديث

أولًا: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه» — الأساس العلمي

السمنة تؤثر على 40%+ من البالغين في أمريكا. تحذير النبي ﷺ من ملء البطن يتطابق مع هذا.

ثانيًا: أدوية GLP-1 تحاكي الاعتدال النبوي

تقلل الشهية 20-30% — تحقق دوائيًا ما أرشد إليه النبي ﷺ سلوكيًا. الفارق: النبي أرشد منذ 14 قرنًا بلا دواء، والمعاصرون يحتاجون حقنة أسبوعية بمئات الدولارات!

ثالثًا: متلازمة الأيض = تسلسل الغزالي

سلسلة الغزالي (بطن ← شهوات ← مال ← تنافس ← أمراض) تتطابق مع متلازمة الأيض: سمنة ← مقاومة أنسولين ← سكري ← ضغط ← قلب وكلى.

رابعًا: الصيام الإسلامي — أقدم صيام متقطع

رمضان هو أقدم نظام صيام متقطع عرفته البشرية. يُنشط الالتهام الذاتي (Autophagy) — العملية التي فاز بسببها يوشينوري أوسومي بنوبل 2016. وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض يوفر نظامًا صحيًا مستمرًا.

خامسًا: مسار طول العمر

مسار mTORC1 الذي تثبطه مثبطات SGLT2 وVSG هو نفسه الذي يُثبط بتقليل السعرات والصيام — «مسار طول العمر» في علم الشيخوخة. النبي ﷺ ربط بين تقليل الطعام والصحة قبل اكتشاف هذا المسار!

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

سورة البقرة: 195

الفصل الثامن

توصيات عملية — من الحكمة النبوية إلى التطبيق اليومي

أولًا: نظام الثلث النبوي

يمكن تطبيق قاعدة الأثلاث النبوية عمليًا بحساب سعة المعدة (التي تتراوح بين 1-1.5 لتر) وتقسيمها: ثلث للطعام الصلب (حوالي 330-500 مل)، وثلث للماء والسوائل، وثلث يُترك فارغًا للهواء وسهولة الهضم. هذا يعني عمليًا أن الوجبة يجب ألا تتجاوز كوبًا إلى كوبين من الطعام.

ثانيًا: الصيام المتقطع على السنة النبوية

يمكن تطبيق الصيام المتقطع باتباع السنة: صيام الاثنين والخميس (يوفر صيامًا متقطعًا مرتين أسبوعيًا)، وصيام الأيام البيض (13-14-15 من كل شهر هجري)، وصيام يوم وإفطار يوم (صيام داود عليه السلام). هذه الأنظمة توفر فترات صيام كافية لتنشيط الالتهام الذاتي وتحسين الحساسية للأنسولين.

ثالثًا: متى يُلجأ إلى الأدوية؟

الاعتدال في الطعام والصيام هما الخط الأول في الوقاية والعلاج. لكن في حالات السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30) أو وجود أمراض مصاحبة كالسكري أو أمراض القلب، قد يكون استخدام أدوية GLP-1 أو مثبطات SGLT2 ضروريًا بإشراف طبي. وفي حالات السمنة الشديدة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40)، قد تكون الجراحة هي الحل الأمثل.

رابعًا: الوقاية خير من العلاج

إن اتباع الهدي النبوي في الاعتدال منذ الصغر يقي من الوصول إلى مرحلة الحاجة إلى الأدوية والجراحة. وتربية الأطفال على عادات غذائية سليمة — مستوحاة من السنة النبوية — هي أفضل استثمار في صحتهم المستقبلية. فالوقاية بتطبيق «لقيمات يقمن صلبه» أفضل وأرخص من حقنة أسبوعية بمئات الدولارات!

توصية: ابدأ بتطبيق قاعدة الثلث النبوي تدريجيًا — قلّل حصتك 10% كل أسبوع حتى تصل إلى ثلثي ما كنت تأكله. أضف صيام يومين أسبوعيًا (الاثنين والخميس). استشر طبيبك إذا كان مؤشر كتلة جسمك أكثر من 30.

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

سورة الإسراء: 85

الخاتمة

يتضح أن الثورة الطبية المعاصرة في علاج السمنة ليست إلا تأكيدًا لما أرشد إليه النبي ﷺ قبل 14 قرنًا. أبحاثنا في جامعة ميشيغان أثبتت أن تقليل الحمل الأيضي — عبر مثبطات SGLT2 أو جراحة VSG — يُحدث تغيرات جزيئية إيجابية عميقة هي الترجمة العلمية لحكمة النبوة.

إن هذا التوافق المذهل يؤكد أن الإسلام دين العلم والعقل، وأن في سنة النبي ﷺ كنوزًا صحية لم يكتشف العلم الحديث إلا جزءًا يسيرًا منها.

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وأن يشفي مرضى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

وفي الختام، نلخص أهم النقاط التي تناولها هذا الكتاب: أولًا، أن حديث النبي ﷺ في تقسيم المعدة أثلاثًا هو أساس الطب الوقائي الذي سبق العلم الحديث بأربعة عشر قرنًا. ثانيًا، أن تحليل الإمام الغزالي لآفات شره الطعام يتطابق مع متلازمة الأيض. ثالثًا، أن

أدوية GLP-1 ومثبطات SGLT2 وجراحة VSG تحقق دوائيًا وجراحيًا ما أرشد إليه النبي ﷺ سلوكيًا. رابعًا، أن أبحاثنا في جامعة ميشيغان أثبتت أن تقليل الحمل الأيضي يحمي الكلى والقلب عبر آليات جزيئية مشتركة. وخامسًا، أن الوقاية باتباع الهدي النبوي أفضل وأرخص من أي دواء أو جراحة.

والله أعلم

المراجع العلمية

أولًا: الأبحاث الطبية

1. Schaub JA*, AlAkwaa FM* et al. SGLT2 inhibitors mitigate kidney tubular metabolic and mTORC1 perturbations in youth-onset T2D. J Clin Invest. 2023;133(5):e164486.
2. Naik AS, Alakwaa FM et al. Metabolic surgery mitigates early kidney injury by suppressing mTORC1/JAK-STAT signaling. 2026.
3. Schaub JA, AlAkwaa FM et al. SGLT2 inhibition increases EGF expression. Kidney International. 2023.
4. Hendershot CS et al. Semaglutide in Alcohol Use Disorder. JAMA Psychiatry. 2025.
5. Jastreboff AM et al. Retatrutide for Obesity. N Engl J Med. 2023;389(6):514-526.
6. FDA: Wegovy for MASH (Aug 2025), Ozempic for CKD (Jan 2025), Zepbound for sleep apnea (2024).
7. GLP-1 Market: USD 70B (2025), projected USD 201B (2033).

ثانيًا: المصادر الإسلامية

8. الألباني. صحيح سنن الترمذي، حديث 2380.

9. ابن حبان. صحيح ابن حبان، حديث 4590.

10. الحاكم. المستدرك على الصحيحين.

11. الغزالي. إحياء علوم الدين — كتاب كسر الشهوتين.

12. ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم.

English Translation Section

القسم الإنجليزي

Introduction

The world is witnessing an unprecedented medical revolution in treating obesity and chronic diseases. GLP-1 receptor agonist drugs such as Ozempic, Wegovy, and Mounjaro have fundamentally changed modern medicine. Yet the essence of this revolution is a scientific confirmation of what the Prophet Muhammad (peace be upon him) taught over fourteen centuries ago.

The Prophet warned: "No human fills a vessel worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat a few morsels to keep his spine straight. But if he must, then one-third for food, one-third for drink, and

one-third for air." Imam Al-Ghazali affirmed that "the stomach is the spring of desires and the breeding ground of diseases."

In this book, we explore how our published research on SGLT2 inhibitors and VSG surgery at the University of Michigan confirms these great Islamic truths.

Chapter 1: The Prophet's Hadith on Moderation in Eating

This hadith, narrated by Al-Miqdam ibn Ma'dikarib and authenticated by Al-Albani, contains three levels: (1) Warning against filling the stomach; (2) Sufficiency with a few morsels — what modern medicine calls "caloric restriction," proven to extend lifespan by 20-30%; (3) Dividing the stomach into thirds for food, drink, and air.

Modern medicine confirms that overeating causes obesity, leading to type 2 diabetes, cardiovascular

disease, chronic kidney disease, MASH, sleep apnea, and cancers. The Prophet articulated these principles 1,400 years before science confirmed them.

Chapter 2: Imam Al-Ghazali on the Afflictions of Gluttony

Al-Ghazali (1058-1111 CE) dedicated a chapter in "Ihya Ulum al-Din" to "Breaking the Two Desires." He identified eight benefits of reducing food, including bodily health and disease prevention — paralleling modern findings on caloric restriction and intermittent fasting. His practical method of gradual reduction mirrors contemporary behavioral nutrition science.

Chapter 2 (continued): Al-Ghazali's Analysis in Modern Context

Al-Ghazali identified ten afflictions of overeating that remarkably parallel modern medical findings: hardening of the heart (cardiovascular disease), physical agitation (metabolic syndrome), diminished understanding (cognitive decline linked to obesity — now being studied with semaglutide for Alzheimer's), excessive sleep (sleep apnea), and physical heaviness limiting activity (obesity-related mobility issues).

His method of gradual food reduction — starting with halal food only, then reducing quantity progressively, adjusting meal timing, and avoiding craved foods — is essentially a 12th-century version of modern behavioral nutrition therapy combined with intermittent fasting protocols.

Chapter 3: The GLP-1 Drug Revolution

GLP-1 receptor agonists mimic the natural gut hormone GLP-1. Semaglutide (Ozempic/Wegovy) achieves 15-20% weight loss; tirzepatide (Mounjaro/Zepbound), a dual GLP-1/GIP agonist, achieves 20-26%. By 2026, FDA approvals include cardiovascular risk reduction, CKD, MASH, and sleep apnea, with trials ongoing in Alzheimer's disease and substance use disorders. The global market reached $70 billion in 2025, projected to exceed $200 billion by 2033.

Chapter 4: SGLT2 Inhibitors and Kidney Protection

Our study (Schaub, AlAkwaa et al., JCI 2023) used single-cell RNA sequencing from kidney biopsies of youth with T2D (aged 12-21). We found SGLT2 inhibitors suppress glycolysis and TCA cycle genes in proximal tubules while enhancing AMPK and FOXO3

pathways, with reduced mTORC1 activity — a pathway linked to kidney inflammation and fibrosis.

Chapter 4 (continued): Additional Findings

Our conference presentations revealed additional SGLT2i mechanisms: improved kidney oxygenation and reduced HIF1A expression (WCN23-0761), enhanced metallothionein pathway protecting against oxidative stress (WCN23-0471), and transcriptional changes extending beyond proximal tubules to the distal nephron — suggesting non-cell autonomous effects. In Kidney International (2023), we showed SGLT2 inhibitors increase renal EGF expression, correlating with improved kidney outcomes and tubular repair signaling.

Chapter 5: VSG Surgery and Molecular Changes

Our 2026 study (Naik, Alakwaa et al.) used scRNAseq on kidney biopsies pre- and 12-months post-VSG in the IMPROVE-T2D cohort. Findings: reduced hyperfiltration, kidney volume, and mesangial matrix; suppression of glycolysis/gluconeogenesis/TCA genes; upregulation of AMPK/FOXO3; decreased mTORC1 and JAK-STAT signaling — remarkably paralleling SGLT2 inhibitor effects.

Chapter 6: Our Published Research

Key publications: (1) JCI 2023 — SGLT2i kidney protection via metabolic reprogramming; (2) 2026 — VSG kidney molecular adaptations; (3) Kidney International 2023 — SGLT2i increases renal EGF

expression; (4) Multiple WCN abstracts on SGLT2i effects.

Chapter 7: Bridging Islamic Wisdom and Modern Medicine

GLP-1 drugs achieve pharmacologically what the Prophet advised behaviorally. Al-Ghazali's cascade parallels Metabolic Syndrome. Islamic fasting activates autophagy (Nobel Prize 2016). The mTORC1 pathway suppressed by SGLT2i and VSG is the same "longevity pathway" inhibited by caloric restriction. The Prophet connected dietary moderation to health 14 centuries before science identified these molecular pathways.

Chapter 7 (continued): Islamic Fasting and Modern Science

Ramadan fasting — abstaining from food and drink from dawn to sunset — is the oldest intermittent fasting system known to humanity. Research confirms it activates autophagy (cellular self-cleaning), improves insulin sensitivity, reduces chronic inflammation, and may protect against neurodegenerative diseases. The voluntary fasts on Mondays and Thursdays, and the three "white days" of each month, provide a continuous health system throughout the year.

The mTORC1 pathway — suppressed by both SGLT2 inhibitors and VSG — is the same pathway inhibited by caloric restriction and fasting. Known in gerontology as the "longevity pathway," its suppression is associated with extended lifespan across species. The Prophet connected dietary moderation to health fourteen centuries before science identified this molecular mechanism.

Our research provides molecular evidence that reducing metabolic burden — whether through pharmacological intervention (SGLT2 inhibitors),

surgical intervention (VSG), or behavioral intervention (dietary moderation as the Prophet taught) — activates the same protective cellular pathways. This convergence is remarkable and underscores the profound wisdom embedded in prophetic guidance.

Chapter 8: Practical Recommendations

The Prophet's thirds rule can be applied practically by dividing stomach capacity: one-third for solid food (~330-500ml), one-third for liquids, and one-third empty. Prophetic intermittent fasting (Mondays and Thursdays, plus the three "white days" monthly) provides sufficient fasting periods to activate autophagy and improve insulin sensitivity. Medications (GLP-1, SGLT2i) should be considered for BMI >30 with comorbidities, and surgery for BMI >40. Prevention through prophetic dietary moderation from childhood is the best investment in future health.

Conclusion

This book demonstrates that the contemporary medical revolution is a scientific confirmation of prophetic guidance. Our research at the University of Michigan shows that reducing metabolic burden produces profound molecular changes that protect organs — the scientific translation of prophetic wisdom on dietary moderation.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع — باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية في جامعة ميشيغان. يركز على استخلاص المعرفة من البيانات الضخمة وتطوير مناهج الطب الشخصي. طوّر أنابيب معلوماتية لتحليل بيانات الأوميكس المتعددة. لديه أكثر من 8 منح بحثية و10+ سنوات خبرة تدريسية.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa — Researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan, Ann Arbor. Focuses on extracting biological insight from big data and developing data-driven personalized medicine approaches. Has over 8 grants as co-investigator and 10+ years of teaching and mentoring experience.

مؤلفات المؤلف

Author's Publications

1. نهاية الكون في القرآن الكريم
2. تغيير الأجيال في مجتمعات المسلمين في الغرب
3. هل انتهت الوحدة اليمنية؟
4. سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي
5. العِلم نورٌ والجهل ظلام
6. الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس
7. مشاكل اليمن عبر الأزمان
8. علامات الساعة في القرآن والسنة
9. فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك
10. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي
11. تصنيف الآيات في القرآن الكريم
12. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة
13. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا

14. وادي السيليكون

15. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا

16. الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب

17. مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي

18. العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين

19. التخطيط للتقاعد

20. دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا

21. كلود كود — الدليل الشامل

22. سر قوة الجامعات الأمريكية

23. الإسلام والصيام والطب — العلم يؤكد السنة

24. أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي منذ 2025

25. دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا

26. الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي

27. الإعجاز العلمي في القرآن — رؤية باحث في علم الجينوم

28. البطن بيت الداء — من حكمة النبي إلى ثورة الأوزمبك

عن الكتاب

يكشف هذا الكتاب عن التوافق المذهل بين
الهدي النبوي في الاعتدال في الطعام
والاكتشافات العلمية الحديثة في مجال
ادوية GLP-1 مثل الاوزمبك والمونجارو
ومثبطات SGLT2 وجراحة تكميم المعدة
يستعرض المؤلف ابحاثه المنشورة في ارقى
المجلات العلمية العالمية التي تثبت ان
تقليل الحمل الايضي يحدث تغيرات جزيئية
ايجابية عميقة وهو المبدا الذي ارشد اليه
النبي صلى الله عليه وسلم

عن المؤلف

د. فضل محمد الاكوع
Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

باحث في البيولوجيا الحاسوبية
والمعلوماتية الحيوية
جامعة ميشيغان
University of Michigan, Ann Arbor

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026